MIND AI × ONTOPOLOGY

AI 中醫問診與開方

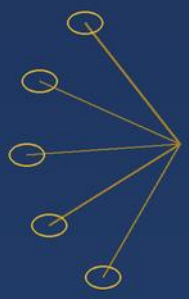
產出準確使用方法完全方案

Mind AI × 本形學（空間本形 × 時間本形）



望聞問切　辨證論治　君臣佐使





四診 × 辨證 × 開方 × 複診

讓每一次問診開方，都有憑有據

方藥內容僅供方法示範，不構成醫療建議

目　錄

寫在前面・三個約定 **3**
導讀・三種讀法 **5**
第一章　認識 AI 中醫問診與開方 **7**
1.1　一個可推理的問診開方副本 7
1.2　形與數，落在中醫 8
1.3　雙本形如何用在問診開方 9
1.4　Mind AI 為底層平台的分工 10
1.5　準確，從哪裡來 11
第二章　六種產出形：問診開方要產出什麼 **12**
2.1　四診形 ExamType：望聞問切的結構化 13
2.2　證型形 SyndromeType：辨證的結論 13
2.3　病機形 MechanismType：因果鏈的中段 14
2.4　治法形 TreatmentType：從證到方的橋 15
2.5　方劑形 FormulaType：君臣佐使的組成 15
2.6　複診形 FollowType：療程的時間本形 17
第三章　四層準確性保證 **18**
3.1　第一層：∩(T) 辨證判準 19
3.2　第二層：演繹骨架——病機推演鏈 20
3.3　第三層：醫理核方 20
3.4　第四層：形證據鏈 21
3.5　空間與時間的交叉驗收 22
第四章　六步驟：準確使用方法的操作流程 **23**
4.1　先用框架四步驟認明需求 23
4.2　六步驟走一次 24
4.3　三層判斷：人體・方劑・證型 24
4.4　挑招、組招、換招 25
第五章　S1–S7 提示詞流水線與不寐醫案 **27**
5.1　S1–S7 總覽 27
5.2　S1 四診採集提示詞 28
5.3　S2 辨證分析與 S3 病機推演 29
5.4　S4 治法立定與 S5 開方組方 30
5.5　S6 核方驗收與 S7 複診調方 32
第六章　誤用、清單與成熟度 **34**
6.1　誤用五種 34
6.2　十問清單 35
6.3　成熟度 L1 到 L4 36
回顧・收束 **37**
附錄 A　術語・招式・記號速查 **38**

寫在前面・三個約定

這是一本「怎麼用」的書。主題是 AI 中醫問診與開方：從望聞問切的四診開始，走到辨證、病機、治法、開方，再到複診調方——整條路要走得準。本書給你的不是中醫教科書，也不是系統操作手冊，而是一套產出準確使用方法的完全方案：每一次問診開方，都產出明確的「形」，每一個形都過得了判準，查得到證據。

理論基礎是本形學——空間本形與時間本形；底層平台是 Mind AI。動筆之前，先立三個約定，全書一體適用。

> **約定一：形，是 Type**
>
> 「形」的英文一律用 **Type**，不是 Form。四診形是 ExamType，證型形是 SyndromeType，方劑形是 FormulaType——全書譯名一致。

> **約定二：理論只用不教**
>
> 本書不重述本形學原理，直接拿工具來用：三括號 [ ] ( ) { }、交集判準 ∩(T)、身份錨 id(C)、remove 三級、框架四步驟、三層判斷、時間本形招式盤。工具的來龍去脈，請回空間本形與時間本形的原典；本書只負責把它們用在問診開方上。

> **約定三：平台只引不述**
>
> Mind AI 是底層平台，本書只引用其分工原則——LLM 管語言，Mind Model 管智慧——不重述平台本身的內容。你要知道的是：問診開方的每一次產出，都跑在這個平台的推理、記憶與學習能力之上。

重要聲明：本書出現的一切方藥內容（含藥味、劑量、加減），僅供方法示範，不構成醫療建議；臨床診療請由合格中醫師診斷處方。

最後，用一張任務地圖收攏全書：六個章節各管一段路，產出形與工具一路相伴。

表 0-1　任務地圖：六段路與它的產出

章	主題	你要學會的事	核心工具
第 1 章（認識）	AI 中醫問診與開方是什麼	看懂可推理副本與雙本形的落點	形 + 數、招式盤
第 2 章（產出）	六種產出形	把問診開方的產出全部結構化	三括號、remove 三級
第 3 章（準確）	四層準確性保證	說得出「為什麼準」	∩(T)、id(C)、證據鏈
第 4 章（操作）	六步驟流程	照步驟走完整條路	框架四步驟、三層判斷
第 5 章（演練）	提示詞與醫案	S1 到 S7 照做即用	七段提示詞
第 6 章（進階）	誤用、清單、成熟度	避開陷阱、評估自己在哪一級	十問清單、L1–L4

導讀・三種讀法

中醫的語言與形＋數的語言，是兩套說法講同一件事。「心脾兩虛」是醫理的結論；證型形 SyndromeType 是同一個結論的結構化寫法。兩套語言之間的翻譯，就是本書要教會你的核心技能。

圖 D-1　兩套語言之間的落差與橋樑

左：醫理的語言　右：形＋數的語言　中間：本形學的對照

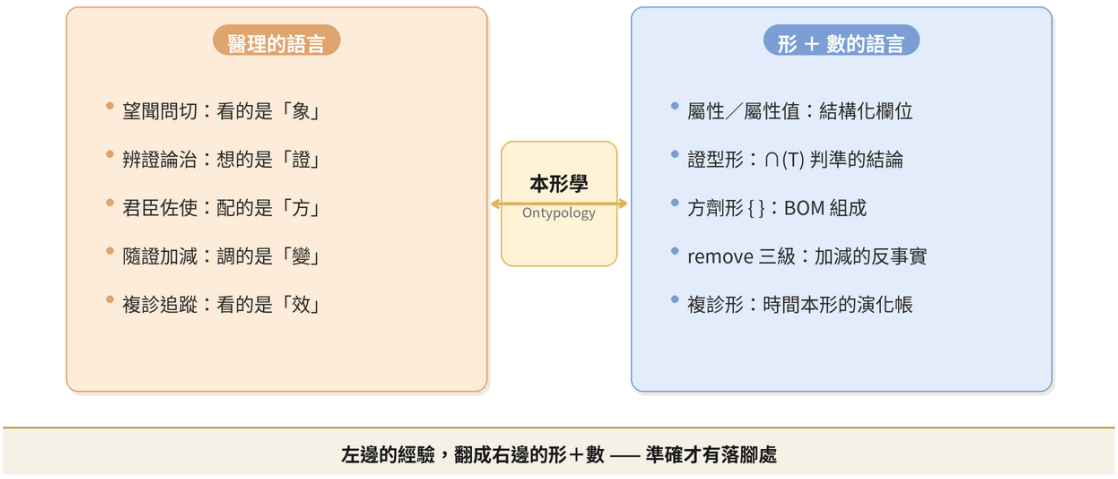


圖 D-1　兩套語言之間的落差與橋樑

表 D-1　兩套語言對照表

醫理的語言	形＋數的語言	翻譯的要點
望聞問切	四診形 ExamType	所見欄位化：有欄位，才查得到
辨證（心脾兩虛）	證型形 SyndromeType	特徵集合 F(T) 過 ∩(T) 判準
病因病機	病機形 MechanismType	因 → 機 → 證的因果鏈
治則治法	治法形 TreatmentType	一機一法，逐環對應
處方（君臣佐使）	方劑形 FormulaType	BOM 組成：{君, 臣, 佐, 使}
複診調方	複診形 FollowType	療效對照＋版本記錄＋演化

本書有三種讀法，按你的需要挑一種，不必從頭啃到尾。

表 D-2　三種讀法

讀法	適合誰	路線
直接用	要馬上開方者	第 5 章的 S1–S7 提示詞照抄，搭配醫案範例對照產出
理解用	要把方法講清楚者	第 2 章產出形 → 第 3 章四層準確性 → 第 5 章演練
導入用	要讓團隊持續變強者	第 1 章 → 第 4 章六步驟 → 第 6 章成熟度 L1–L4

全書用一個貫穿醫案示範：林小姐，三十二歲，失眠約兩個月。從四診採集一路走到複診調方，每一章都會回到她身上。你可以先翻到第 5 章看完整演練，再回頭補理論；也可以順著讀下來，看著同一個醫案一層層被解剖。

第一章　認識 AI 中醫問診與開方



先把對象認清楚。這一章回答四件事：AI 中醫大腦到底是什麼、形與數落在中醫的哪裡、雙本形怎麼用在問診開方、以及「準確」兩個字從哪裡來。讀完本章，你應該能把這套方法一句話說給同行聽。

1.1　一個可推理的問診開方副本

一位老醫師看診時，腦中跑的是什麼？望一眼面色、切一下脈、聽幾句主訴，證型就浮出來了，方也跟著成形。這條思路存在他腦子裡，是隱性的、難以傳授的。AI 中醫問診與開方要做的事情只有一件：把這條思路做成一個可推理的副本——不只給答案，還保留推理的路。

圖 1-1　把醫者的判斷，做成一個可推理的副本

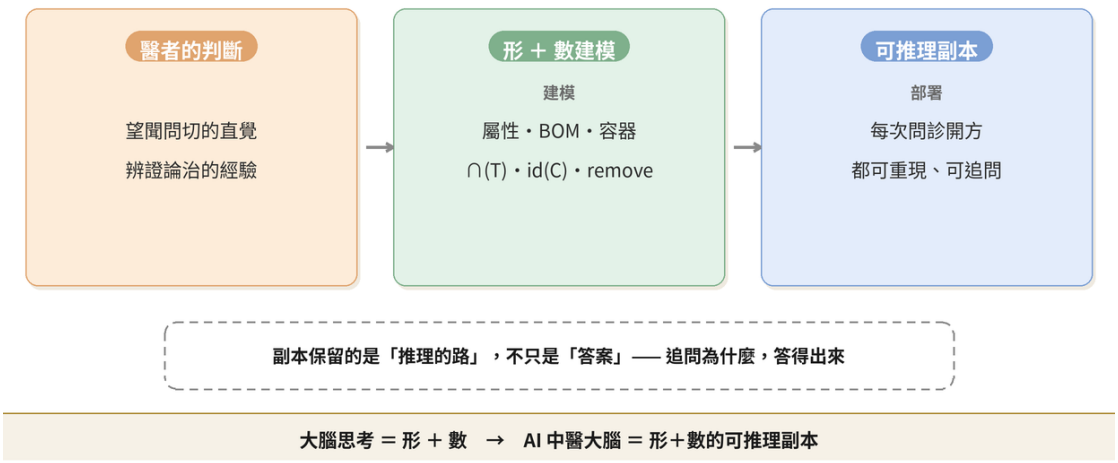


圖 1-1　把醫者的判斷，做成一個可推理的副本

副本的關鍵在「可推理」。你問它為什麼開歸脾湯，它答得出：因為證型是心脾兩虛，因為脈細弱、心悸健忘過得了這個證型的判準，因為治法是補益心脾、養血安神，所以方從法出。答案背後有一條可以追問的路，這條路用形與數鋪成。

1.2　形與數，落在中醫

大腦思考 = 形 + 數。數描述量——劑量、脈率、病程天數；形描述結構——證型長什麼樣、方劑由什麼組成、病機如何串聯。中醫兩樣都不缺：缺的是把「形」寫清楚的語言。

圖 1-2　形與數，各自落在中醫的哪裡

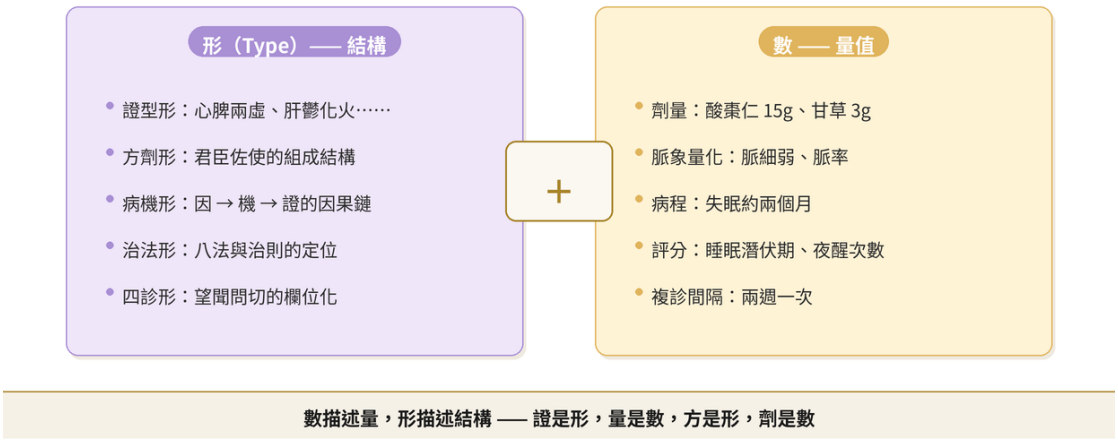


圖 1-2　形與數，各自落在中醫的哪裡

中醫傳統強調「象」與「悟」，結構化程度低，於是同一份四診資訊，兩位醫師可能開出兩張不同的方，誰也說不清差在哪一環。把形立起來，差異就被逼到檯面上：是 F(T) 收得不同？是病機鏈斷了一環？還是治法選了另一條？對得出來，才談得上準確。

表 1-1　形 + 數在中醫的落點

層面	形（結構）	數（量值）
四診	四診形：望聞問切四欄位	舌色、脈率、病程天數
辨證	證型形：F(T) 與 ∩(T)	症狀程度評分
病機	病機形：因→機→證鏈	病程階段
治法	治法形：治則 + 八法歸類	療程長度
方劑	方劑形：君臣佐使 BOM	藥味劑量
複診	複診形：版本記錄	療效差值

1.3　雙本形如何用在問診開方

空間本形與時間本形，在問診開方裡各管一半。空間本形管「看清楚」：把人、證、方的結構立起來——屬性是 X 軸，組成是 Y 軸，容器是 Z 軸，三條軸把一個對象釘在座標上。時間本形管「做下去」：診、治、調是一連串動作，每個動作是一招——時間本形 = 動詞 = 函式 = 招式。

圖 1-3　雙本形如何用在問診開方

左：空間本形三條軸（把「人・證・方」看清楚）　右：時間本形招式盤（把「診・治・調」做下去）

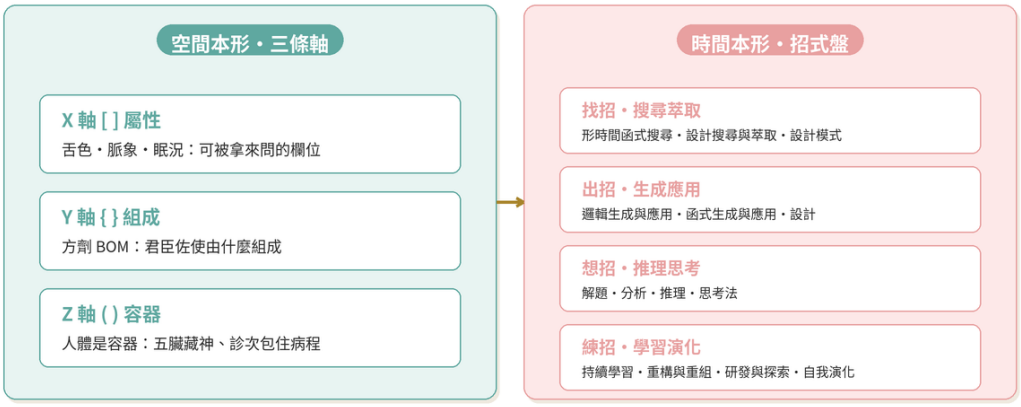


圖 1-3　雙本形如何用在問診開方

表 1-2　空間本形三條軸 × 中醫

軸	括號	中醫的落點
X 軸・屬性	[ ]	舌色、脈象、眠況、二便……可被拿來問的欄位；屬性值是欄位裡的選項
Y 軸・組成	{ }	方劑 BOM：君臣佐使由哪些藥味組成；remove 三級對應加減尺度
Z 軸・容器	( )	人體是容器（五臟藏神、氣血津液）；診次包住病程；id(C) 錨定身份

時間本形的招式盤有四組十四招。本書只列綱目、直接取用；招式的定義與推導回到時間本形原典。

表 1-3　時間本形招式盤 × 中醫落點（四組）

組	招式	問診開方的用法
找招	形時間函式搜尋・設計搜尋與萃取・設計模式	找相似醫案、萃取證型特徵、套用成方配伍模式

組	招式	問診開方的用法
出招	邏輯生成與應用・函式生成與應用・設計	病機推演、治法生成、組方加減（開方就是設計）
想招	解題・分析・推理・思考法	辨證分析、因果推理、逆向從方測證、鑑別診斷
練招	持續學習・重構與重組・研發與探索・自我演化	醫案歸檔、調方重構、探索新方、越開越準

把兩半合起來：空間建形讓「人・證・方」有結構，時間出招讓「診・治・調」有動作。六種產出形（第 2 章）是空間的結晶，六步驟（第 4 章）是時間的套路，S1 到 S7（第 5 章）是每一招的具體出手式。

1.4　Mind AI 為底層平台的分工

這套方法跑在 Mind AI 上。分工原則一句話：LLM 管語言，Mind Model 管智慧。LLM 負責聽懂主訴、寫出四診記錄、召回方劑文獻；Mind Model 負責統一知識、深度推理、長期記憶與持續學習。辨證論治的演繹由 Mind Model 承擔，語言的進出由 LLM 承擔。

圖 1-4　Mind AI 為底層平台的分工

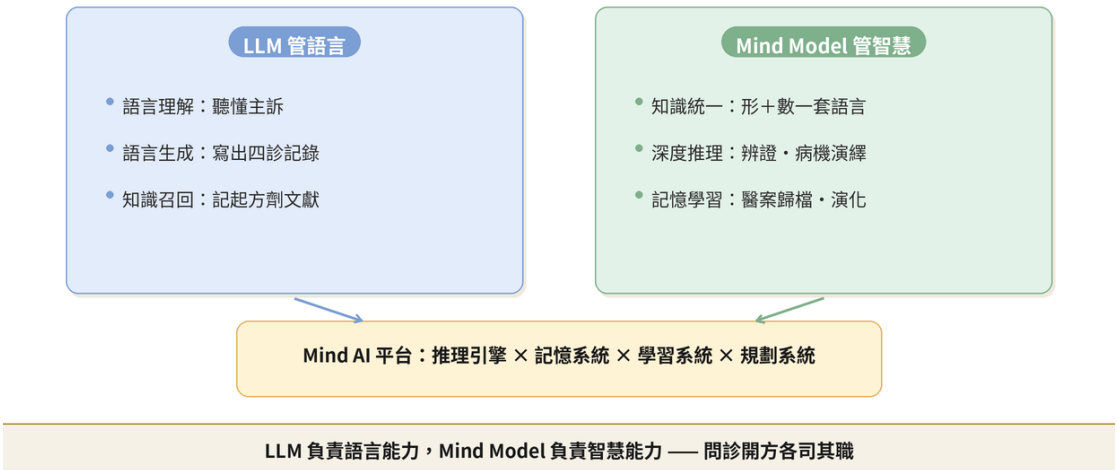


圖 1-4　Mind AI 為底層平台的分工

分工落到問診開方的每一站：S1 的四診記錄由 LLM 寫成，S2、S3 的辨證與病機演繹由 Mind Model 推理，S5 查文獻是兩者合力，S7 的醫案歸檔與經驗回寫則是 Mind Model 的記憶與學習能力在收束。語言進出不缺席，智慧推理不外包——這就是底層平台的意義。

1.5　準確，從哪裡來

「AI 開的方能信嗎？」這個問題必須有結構性的答案，而不是感覺。本書的答案是四層準確性保證，第 3 章逐層展開，這裡先一句話預告每一層：辨證有判準（∩(T) 過了才收進證型）、推理有骨架（病機鏈環環相扣）、配方有核驗（君臣佐使 + 配伍禁忌）、全程有證據（每一步指得回四診）。四層都過，才准出方。

還有一半準確來自時間維度：複診讓每一次療效都變成下一診的經驗，醫案卷越來越厚，判準越來越精。空間的四層管「這一張方準不準」，時間的演化管「下一張方更不更準」。

本章重點

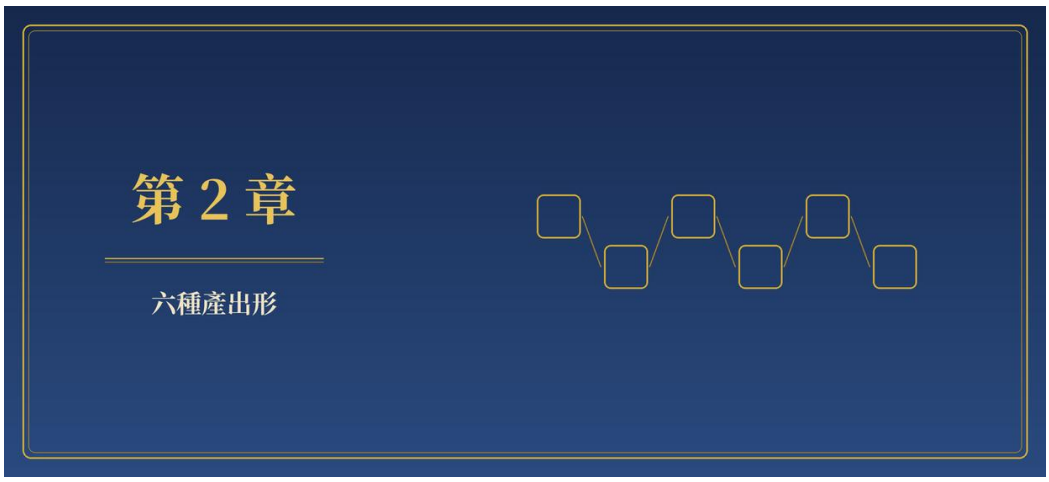
AI 中醫大腦 = 問診開方思路的可推理副本：答案背後有可追問的路。

形描述結構、數描述量值；把形立起來，準確才有一致的語言。

空間本形三條軸看清楚「人．證．方」，時間本形招式盤做下去「診．治．調」。

Mind AI 分工：LLM 管語言，Mind Model 管智慧；準確由四層保證 + 時間演化。

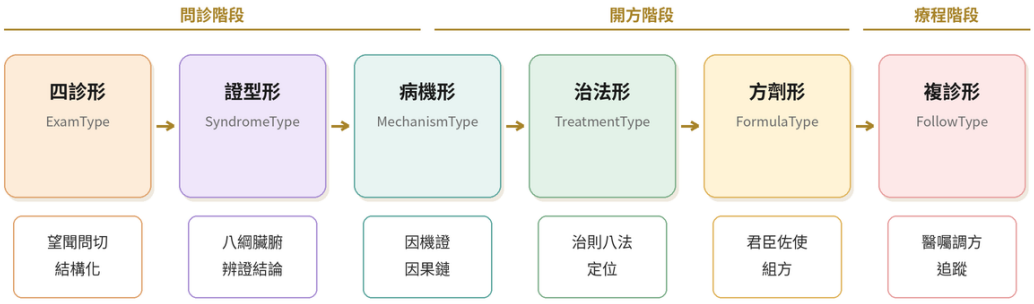
第二章　六種產出形：問診開方要產出什麼



問診開方不是一次性的對話，而是六種產出物的接力：四診形、證型形、病機形、治法形、方劑形、複診形。每一種都是一種形 Type，都有明確的欄位與判準。形定下來，產出才可累積、可比較、可驗收。

圖 2-1　問診開方的六種產出形

每一站都有明確的輸入與輸出，站站可查、環環可問



四診 → 證型 → 病機 → 治法 → 方劑 → 複診：每一步都是一種形

圖 2-1　問診開方的六種產出形

先記總表，後面六節逐一拆開。每一節都回答同樣的三件事：這個形的欄位是什麼（屬性 X 軸）、由什麼組成（組成 Y 軸）、住在什麼容器裡（容器 Z 軸）。

表 2-1　六種產出形總表

產出形	英文名	一句話	判準
四診形	ExamType	望聞問切的結構化記錄	所見齊全、不臆補

產出形	英文名	一句話	判準
證型形	SyndromeType	辨證的結論	∩(T) 交集判準
病機形	MechanismType	因→機→證的因果鏈	環環有四診證據
治法形	TreatmentType	從證到方的橋	一機一法對應
方劑形	FormulaType	君臣佐使的組成	配伍核驗 + remove 三級
複診形	FollowType	療程的時間本形	前後對照 + 版本記錄

2.1 四診形 ExamType：望聞問切的結構化

四診形是整條路的地基。它把「望、聞、問、切」四診變成四個欄位群，每個欄位群下是可填的屬性與屬性值——屬性是「可以被拿來問的問題」，屬性值是這個問題在本診的答案。欄位定死，資訊才不會漏；漏了欄位會顯示「未採集」，而不是被沉默地跳過。

表 2-2 四診形 ExamType 欄位表

欄位群	核心屬性	屬性值示例（林小姐）
望	面色、形體、舌色、舌苔、神態	面色少華；形體偏瘦；舌淡；苔薄白；神疲
聞	語聲、氣息、特殊氣味	語聲低微；無特殊氣味
問	眠況、心悸、食納、二便、月經、情志	難入睡多夢易醒；心悸健忘；食少納呆；二便調；經量少色淡；思慮多
切	脈象、腹診、壓痛	脈細弱；腹軟無壓痛

實務上有兩條鐵律。第一，客觀所見先行：舌象、脈象必填，缺了就標「未採集」並列入補問清單，絕不用猜的補上。第二，程度與時間要寫進屬性值：「失眠約兩個月」「夜醒二至三次」比「睡不好」有用得多——後續辨證的特徵集合 F(T) 是從這裡長出來的。

2.2 證型形 SyndromeType：辨證的結論

證型形是辨證的結論，寫法是「不寐．心脾兩虛證」這樣的雙層結構：病名（不寐）+ 證型（心脾兩虛）。它不是一句話，而是一個集合的會員資格判定——[不寐] 是抽象集合，一個病人要進得來，特徵集合 F(T) 必須過得了這個證型的交集判準 ∩(T)。

圖 2-2　三種括號，同一個不寐



圖 2-2　三種括號，同一個不寐

三種括號在辨證現場各有職責：[ ] 定資格——這個表現歸不歸入不寐、是不是心脾兩虛；( ) 定身份——這位林小姐是一個容器，五臟神志氣血住在裡面，(本次診次) 包住這段病程，id(C) 把人與病程錨定；{ } 定結構——方劑由什麼組成，下一節與 2.5 會用到。

表 2-3　證型形 SyndromeType：定位與判準

步驟	內容	林小姐的判定
病名定位	不寐：以不能獲得正常睡眠為主訴	主訴失眠約兩個月 → 病名不寐
八綱定位	陰陽、表裡、寒熱、虛實	裡、虛、寒象不顯 → 裡虛證
臟腑定位	心、脾、肝、膽何者受累	心悸健忘 + 食少納呆 → 心脾
F(T) 對照	特徵集合與候選證型逐一比對	面色少華、舌淡、脈細弱、經量少
排除鑑別	相似證型為何不取	非肝鬱化火（無急躁口苦脈弦）

2.3　病機形 MechanismType：因果鏈的中段

證型形回答「是什麼」，病機形回答「為什麼」。它把病因、病機、證候串成因果鏈：思慮過度暗耗心血，脾失健運、氣血生化乏源，心神失養，於是不寐。這條鏈是演繹骨架的中段——前接四診證據，後接治法方藥（第 3 章詳述）。

病機形有兩個欄位規矩。其一，每一環都要指得回四診裡的證據：說「脾失健運」，就得有食少納呆、倦怠之類的所見撐著；指不回去的環，是臆測，砍掉。其二，鏈是有序的：因果順序亂了，治法就會抓錯重點——先補血還是先健脾，取決於哪一環是主機。

2.4　治法形 TreatmentType：從證到方的橋

治法形是病機與方劑之間的橋：病機說「心血不足、脾運不健、心神失養」，治法就立「補益心脾、養血安神」——一機一法，逐環對應，不多不少。治則是大方向（虛則補之），治法是具體落點（補心脾、養心神），再加上八法歸類（此例屬補法），三欄寫齊，治法形才完整。

治法形的判準只有一條：方開出來之後，每一味藥要指得回治法、每一句治法要指得回病機。橋若偷工減料，方就成了藥味的堆砌——這正是第 6 章誤用五種裡最常見的一種。

2.5　方劑形 FormulaType：君臣佐使的組成

方劑形是本書最重要的產出，它就是一張 BOM（組成集合 { }）：底方為根，君臣佐使四級為幹，藥味劑量為葉。君藥針對主證主機，臣藥助君為力，佐藥照顧兼證或防副作用，使藥調和諸藥、引經報使。每一味藥有名字、有劑量、有任務——三樣缺一，BOM 就不完整。

圖 2-3　方劑形 FormulaType：君臣佐使就是一張 BOM

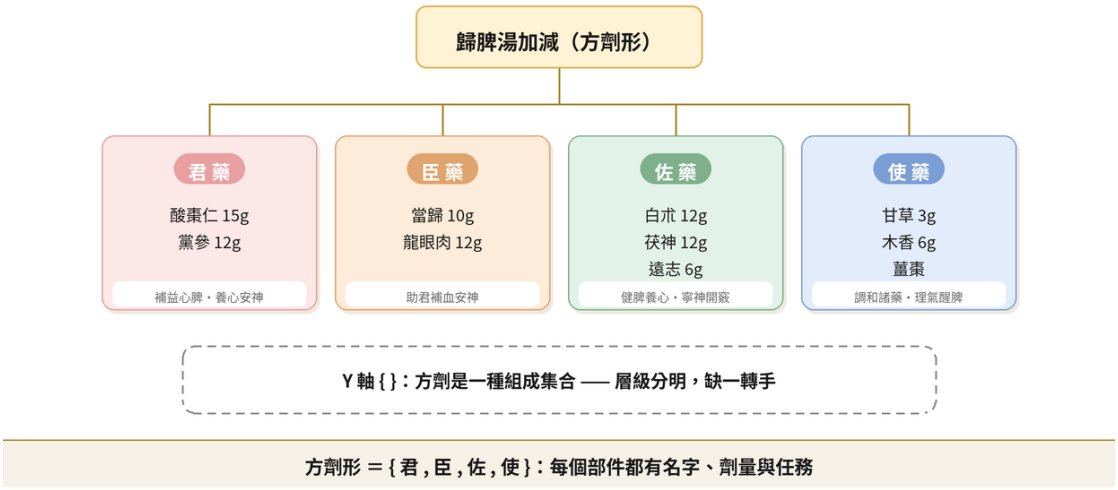


圖 2-3　方劑形 FormulaType：君臣佐使就是一張 BOM

表 2-4　方劑形 BOM：歸脾湯加減（僅供示範）

層級	藥味與劑量	任務
君	黃耆 15g、黨參 12g、酸棗仁 15g	補益心脾、養心安神，直指主機
臣	當歸 10g、龍眼肉 12g、茯神 12g	養血安神，助君為力
佐	白朮 12g、遠志 6g	健脾助運、寧神開竅，顧兼證
使	木香 6g（後下）、甘草 3g、生薑 3 片、大棗 5 枚	理氣醒脾使補而不滯、調和諸藥

加減是方劑形的動態欄位，尺度由 remove 三級決定：單味、藥對（角）、方根（底方）。動手加減之前，先做反事實問句——「拆下來，它還認得自己嗎？」單味被移除，問的是任務會不會落空；藥對被移除，問的是不是成對失守；方根被移除，問的是整張方的骨架還在不在。三問都過，才動這一級。

圖 2-4　remove 三級：加減之前，先問拆下來認得自己嗎

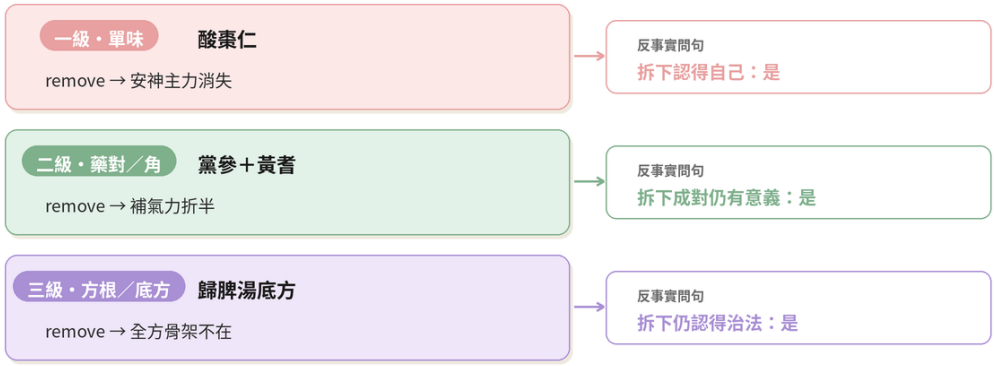


圖 2-4　remove 三級：加減之前，先問拆下來認得自己嗎

表 2-5　remove 三級 × 加減尺度

級	對象	反事實問句	加減示例（僅供示範）
一級	單味	拿掉它，任務落空嗎	眠差多夢 → 加柏子仁 10g 強化安神任務
二級	藥對 / 角	拿掉它們，成對失守嗎	黨參 + 黃耆一對補氣，除非改方否則不輕拆
三級	方根 / 底方	拿掉骨架，治法還站得住嗎	若證型轉變（如轉肝鬱化火），才換底方

2.6　複診形 FollowType：療程的時間本形

複診形是療程的時間本形：它把「診・治・調」拉成一條時間線。欄位有四組——療效對照（前後四診的差值）、證型轉變（守證還是轉證）、調方決定（守方、加減、換方，附理由）、演化紀錄（這次學到什麼，回寫醫案卷）。複診不是重來一次問診，而是帶著前診卷宗的比對。

id(C) 在這裡特別重要：容器的身份要錨定，「林小姐這一段病程」才追得蹤、比得了、積得累。每一次複診都是醫案卷的新版本，舊版本不覆蓋——這正是時間本形「持續學習、自我演化」

兩招的落點。

本章重點

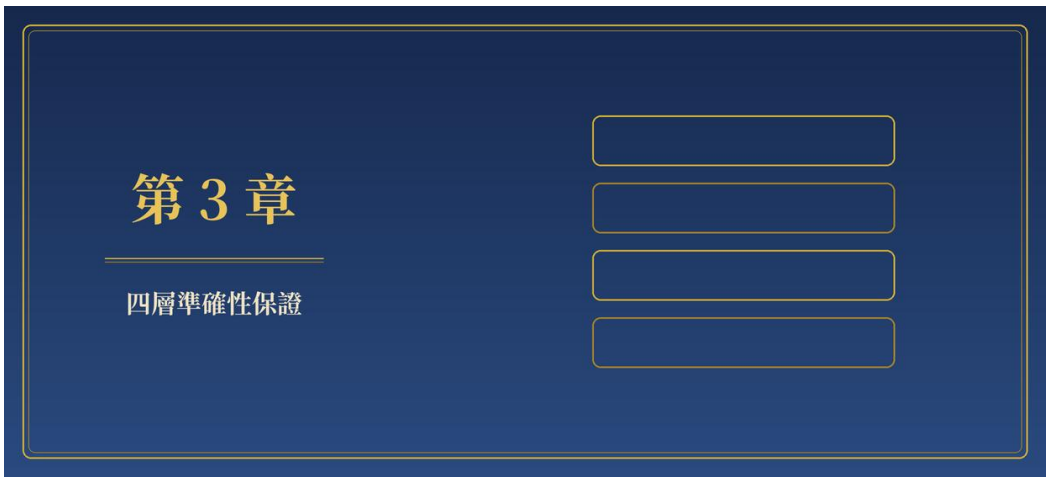
六種產出形接力：四診 → 證型 → 病機 → 治法 → 方劑 → 複診，每種形都有欄位與判準。

三括號分工：[ ] 定資格、( ) 定身份、{ } 定結構；證型是集合會員的判定。

方劑形是一張 BOM：君臣佐使層級分明，每個藥味有名字、劑量、任務。

加減尺度由 remove 三級決定；複診形用 id(C) 錨定病程，讓經驗可以累積。

第三章　四層準確性保證



準確不能靠感覺。本章把「為什麼這張方可以信」拆成四層：辨證有判準、推理有骨架、配方有核驗、全程有證據。四層是四道關，每道關各有各的問法，也各有各的退件處理。

圖 3-1　四層準確性保證：從判準到證據

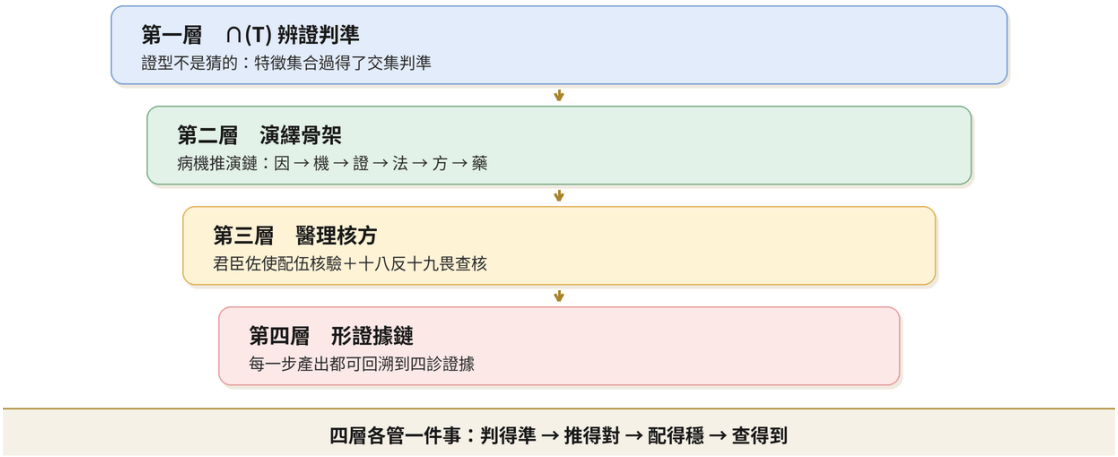


圖 3-1　四層準確性保證：從判準到證據

四層各有各的退件處理：∩(T) 不過，退回補問四診；病機鏈斷環，退回重推；配伍有疑，退回重新組方；證據斷鏈，退回補齊。退件路徑寫得明確，流水線才敢放行到下一關——第 5 章的 S1 到 S7 會把這些退件路徑一一落到提示詞裡。

3.1　第一層：∩(T) 辨證判準

第一層管辨證。證型形 T 由兩樣東西決定：特徵集合 F(T) 與交集判準 ∩(T)。病人的表現湊成

一個特徵集合，候選證型各有各的判準——兩者相交，過得了關才收得進來。這不是查表比對單一症狀，而是整組特徵的集合判定，所以同一個主訴（失眠）會分流到四種不同證型、四張不同的方。

圖 3-2　∩(T) 辨證判準：不寐四證型的鑑別漏斗

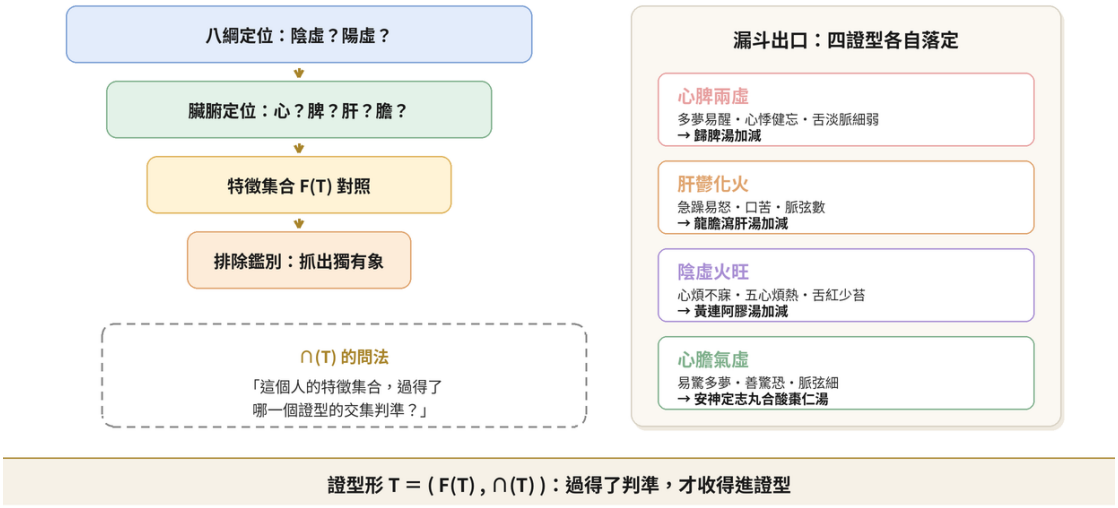


圖 3-2　∩(T) 辨證判準：不寐四證型的鑑別漏斗

表 3-2　∩(T) 鑑別：不寐四證型（方劑僅供示範）

證型	F(T) 特徵要點	∩(T) 獨有象	底方
心脾兩虛	多夢易醒、心悸健忘、食少倦怠	面色少華、脈細弱	歸脾湯加減
肝鬱化火	急躁易怒、口苦、便秘溲赤	脈弦數、苔黃	龍膽瀉肝湯加減
陰虛火旺	心煩不寐、五心煩熱、盜汗	舌紅少苔、脈細數	黃連阿膠湯加減
心膽氣虛	易驚多夢、善驚恐、氣短	脈弦細、觸事易驚	安神定志丸合酸棗仁湯

漏斗的最後一關是排除鑑別：要寫得出「為何不是另一個證型」。林小姐沒有急躁口苦、脈不弦數，所以肝鬱化火出局；沒有五心煩熱、舌不紅，所以陰虛火旺出局。排除寫得出來，才代表 ∩(T) 真的跑過一遍，而不是背答案。

3.2　第二層：演繹骨架——病機推演鏈

第二層管推理。從病因到藥味，是一條六環的演繹鏈：因 → 機 → 證 → 法 → 方 → 藥。每一環都是一次演繹推理（時間本形・推理招），每一環都要有四診證據或上一環的支撐。鏈上任何一環斷了，後面全不作數——這就是「方從法出、法從證立」的結構化版本。

圖 3-3　演繹骨架：病機推演鏈一環扣一環



圖 3-3　演繹骨架：病機推演鏈一環扣一環

表 3-3　病機推演鏈欄位（林小姐示例）

環	內容	支撐證據
因	思慮過度	問診：思慮多、文職
機	暗耗心血、脾失健運、氣血乏源	心悸健忘、食少納呆、倦怠乏力
證	心脾兩虛（不寐）	面色少華、舌淡苔薄白、脈細弱
法	補益心脾、養血安神（補法）	對應主機：心脾兩虛、心神失養
方	歸脾湯加減	底方主治與證型相合
藥	君臣佐使逐味指回治法	見表 2-4、表 5-4

3.3　第三層：醫理核方

第三層管配方。演繹鏈保證「方從法出」，但法對了方仍可能開歪——所以要核方。核方分兩大關：結構關與安全關。結構關查君臣佐使是否齊全、每味藥的任務是否明確、有沒有「說不出任務的藥」混進來；安全關查配伍禁忌（十八反、十九畏）、劑量是否在常用範圍、特殊人群提示（妊娠、經期、過敏史）。

核方的問法是反事實的——remove 三級再跑一次：這張方少任何一味，哪個任務會落空？答得出來，表示每味藥都在崗位上；答不出來，這味藥就可疑。核方不過的處置很明確：指出斷點，退回 S5 重新組方，絕不帶著疑點出方。

3.4　第四層：形證據鏈

第四層管查證。形證據鏈把六種產出形串成一條可回溯的路：處方指得回治法，治法指得回病機，病機指得回證型，證型指得回四診。追問「憑什麼」的時候，每一步都答得出上一步——像病歷，也像判決書的說理。

圖 3-4　形證據鏈：每一步都回得了頭

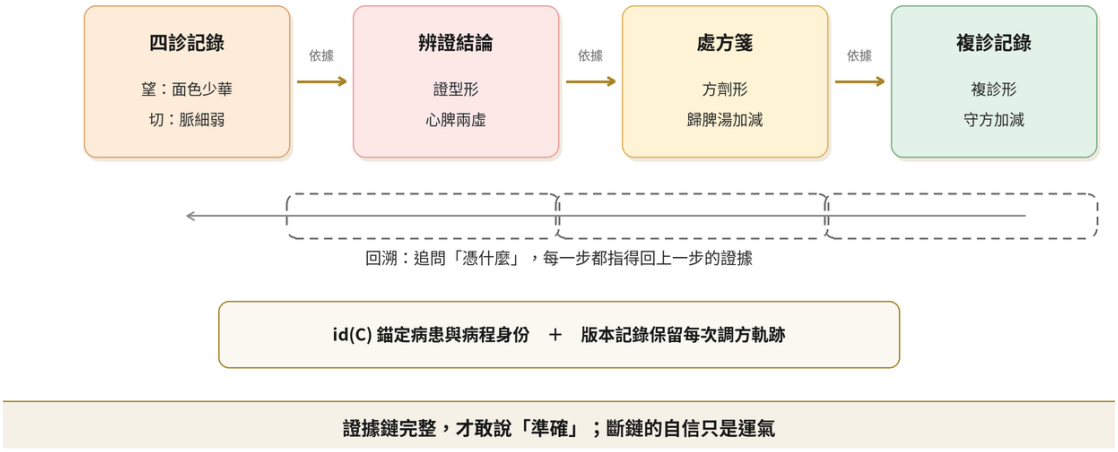


圖 3-4　形證據鏈：每一步都回得了頭

表 3-4　形證據鏈欄位

產出	要存什麼	回溯到
四診形	原始所見 + 未採集清單	問診當下（對話記錄）
證型形	F(T) + ∩(T) 對照 + 排除鑑別	四診形
病機形	因果鏈逐環 + 證據指涉	四診形、證型形
治法形	治則治法 + 對應病機環	病機形
方劑形	君臣佐使 + 加減理由 + 核方報告	治法形
複診形	療效對照 + 調方版本	前診卷宗（id(C) 串起）

3.5　空間與時間的交叉驗收

四層是空間視角的把關——這一張方、這一刻的準確。別忘了時間視角：複診形帶來療效回饋，讓判準可以被驗證與修正。空間×時間的交叉驗收，做法是把複診結果倒回去比對當初的四層：當初判的心脾兩虛，用方之後眠況改善了嗎？改善了，四層的判定被強化；沒改善，就要重開卷——是 F(T) 收錯了象，還是病機鏈抓錯主機？

這套倒查就是時間本形「自我演化」的具體動作：每一次交叉驗收，醫案卷就多一頁結論，∩(T) 判準就多一分火候。四層管準確的下限，演化管準確的上限。

本章重點

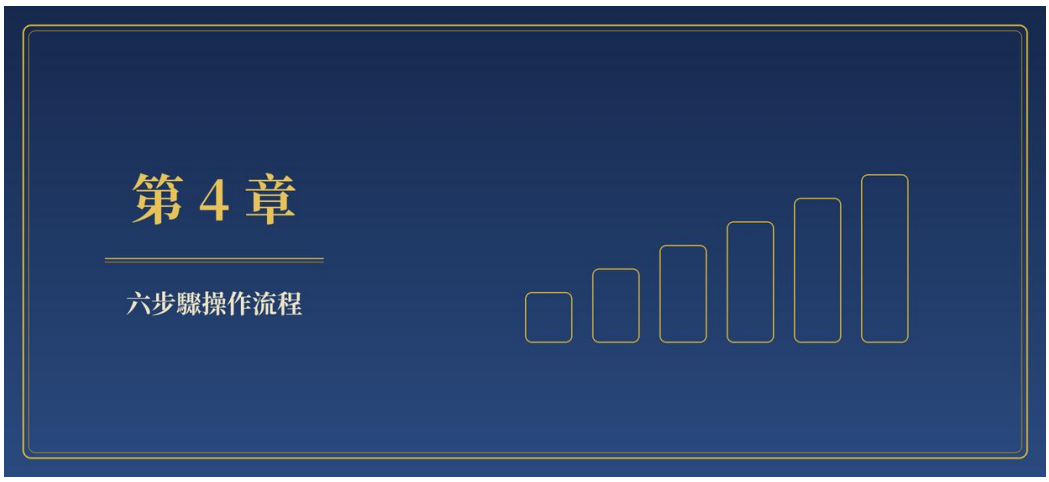
四層各管一件事：∩(T) 管辨證、演繹鏈管推理、醫理核方管配方、形證據鏈管查證。

排除鑑別寫得出來，才算真的跑過 ∩(T)；斷一環的病機鏈，後面全不作數。

核方走結構關與安全關，remove 反事實問句是最快的自查。

空間四層管這一張方，時間演化管下一張方；交叉驗收讓判準越用越精。

第四章　六步驟：準確使用方法的操作流程



產出形是「東西」，這一章是「動作」。六步驟把前兩章的產出與判準排成一條可重複走的路：認明情境、分軸建形、挑選擴式、生成產出、判準驗收、歸檔演化。每一診走一遍，醫案卷就厚一頁。

圖 4-1　六步驟：把方法走成一條路



圖 4-1　六步驟：把方法走成一條路

4.1　先用框架四步驟認明需求

六步驟之前先做框架四步驟——這是空間本形的開場動作，用來把「這次看診的需求」認清楚，而不是一頭栽進症狀堆裡。四步依序是：定對象（這次的容器是誰、id(C) 是什麼）、定範圍（本次診次要處理什麼、不處理什麼）、定目標（療效指標是什麼）、定約束（體質、經期、藥

物過敏、生活限制）。

表 4-1　框架四步驟 × 問診開方

步驟	要問的問題	林小姐示例
定對象	容器是誰？id(C) 是什麼？	林小姐，32 歲，文職；本段病程 = 失眠約兩個月
定範圍	本診處理什麼？不碰什麼？	處理失眠主訴；先不動月經調理，列入後續
定目標	療效指標是什麼？	入睡時間縮短、夜醒次數下降、心悸減輕
定約束	體質、禁忌、生活限制？	無妊娠；經期將至；忌濃茶咖啡；工作壓力大

4.2　六步驟走一次

框架認明之後，六步驟依序出手。注意它與產出形的對位：前三步是準備（情境、形、招），第四步生成六種產出形，第五步跑四層準確性，第六步把結果沉澱成時間本形的演化。

表 4-2　六步驟總表

步	動作	產出	對應章
1	認明情境（框架四步驟）	情境說明：對象、範圍、目標、約束	本章 4.1
2	分軸建形（三條軸）	四診形立欄位，辨證與方劑的骨架就位	第 2 章（產出形）
3	挑選擴式（招式盤）	招式挑選單：本診要用哪幾招	本章 4.4
4	生成產出	六種產出形依序落地	第 5 章（演練）
5	判準驗收（四層）	核方報告；不過就退件	第 3 章（準確）
6	歸檔演化	醫案入卷、經驗回寫、判準精進	本章 + 第 6 章

4.3　三層判斷：人體・方劑・證型

操作途中不斷回頭做判斷的時候，用形邏輯的三層判斷，由外而內三問：容器判斷——這個問題涉及的容器是誰？人體是容器，五臟神志住在裡面，診次也是容器，包住這段病程，身份由 id(C) 錨定。組成判斷——談的這個方由什麼組成？remove 三級的反事實問句在這裡跑。抽象判斷——這個表現歸得進 [證型] 嗎？∩(T) 說了算。

圖 4-2　三層判斷：人體・方劑・證型

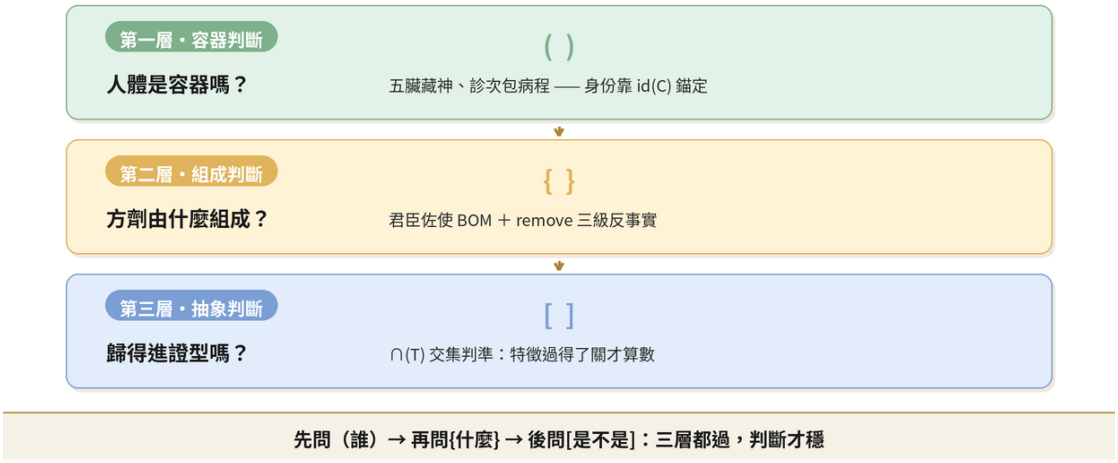


圖 4-2　三層判斷：人體・方劑・證型

三層的順序不能亂：先確認容器與身份，才不會張冠李戴（把別人的醫案套在這位病人身上）；再看組成，才不會脫離方劑結構談藥味；最後才做抽象歸類，判準才有所依附。遇到卡關的案例，多半是跳層——跳過容器直接談證型，是最常見的一種。

4.4　挑招、組招、換招

時間本形的招式盤不是每診全上，而是按情境挑選、按需要組合、按結果更換。挑招看情境的疑難點：證型難辨就上「分析＋推理」，方劑難組就上「設計搜尋與萃取＋設計模式」，療效不動就上「解題＋重構與重組」。組招是把前後招串成流水線——S1 到 S7 本身就是一條標準組招。換招是診斷性動作：這條路推不動，退回上一環換一招再推。

表 4-3　招式挑選單（情境 → 招式）

情境	首選招式	組合用法
四診資訊雜亂	分析・形時間函式搜尋	先分析拆欄位，再以相似醫案補齊漏問
證型難辨、象不典型	推理・思考法	正向從象推證＋逆向從方測證交叉驗證
方劑難組、加減猶豫	設計搜尋與萃取・設計模式	先搜相似醫案的成方模式，再按 BOM 調整
療效不佳、要找原因	解題・逆向推理	從未效倒推：F(T) 錯？主機抓錯？劑量不足？
多診之後要精進	持續學習・自我演化	醫案卷複盤，把結論回寫判準

本章重點

框架四步驟先認需求：定對象、定範圍、定目標、定約束，再進六步驟。

六步驟對位產出形與四層準確性：準備三步、生成一步、驗收一步、演化一步。

三層判斷由外而內：(容器) → {組成} → [抽象]，跳層是卡關最常見的原因。

招式要挑、要組、要換；S1–S7 就是標準組招，第 5 立即演練。

第五章　S1–S7 提示詞流水線與不寐醫案



這一章是演練場。七段提示詞 S1–S7 對應六種產出形與核方報告，每段都是「任務 → 輸入形 → 輸出形 → 判準 → 禁止事項」的寫法：上一站的產出是下一站的輸入，形形相扣。全部用林小姐的不寐醫案實跑一遍——照抄提示詞，換上你的病人，就是可用的方法。



圖 5-1　S1–S7 提示詞流水線

5.1　S1–S7 總覽

先看全景：七段各管一段路，輸入輸出都是明確的形。中間任何一段被核方打回，就退回該段重做——退件路徑寫在表的最後一欄。

表 5-1　S1–S7 總表

段	任務	輸入形	輸出形	不過退件
S1	四診採集	主訴對話	四診形 ExamType	缺欄位 → 補問
S2	辨證分析	四診形	證型形 SyndromeType	∩(T) 不過 → 退 S1
S3	病機推演	證型形	病機形 MechanismType	斷環 → 退 S2
S4	治法立定	病機形	治法形 TreatmentType	不對應 → 退 S3
S5	開方組方	治法形	方劑形 FormulaType	核方不過 → 退 S5
S6	核方驗收	S1–S5 全卷	核方報告	任一層不過 → 退該段
S7	複診調方	前診卷宗 + 新四診	複診形 FollowType	療效存疑 → 重開卷

圖 5-2　不寐醫案：一次完整的問診開方



圖 5-2　不寐醫案：一次完整的問診開方

5.2　S1 四診採集提示詞

S1 的任務只有一個：把對話變成結構化四診記錄。最容易犯的錯是順手下判斷——所以提示詞明文禁止在本步驟寫證型。

提示詞 S1　四診採集

【任務】你是中醫問診助理。把病患主訴與對話整理成結構化四診記錄（四診形 `ExamType`）。

【輸入】病患主訴與對話記錄。

【輸出格式】表格四欄：望、聞、問、切；每欄列出具體所見。

【判準】舌象、脈象必填；症狀須含程度與時間；缺漏欄位寫「未採集」並列補問清單。

【禁止】不得在本步驟寫出證型或處方；不得用推測補齊未採集欄位。

表 5-2　S1 產出範例：林小姐四診形

欄位	產出內容
望	面色少華、形體偏瘦、舌淡、苔薄白、神疲
聞	語聲低微，無特殊氣味
問	失眠約兩個月：難入睡、多夢易醒、夜醒二至三次；心悸健忘；食少納呆；倦怠乏力；思慮多；月經量少色淡；二便調
切	脈細弱，腹軟無壓痛
未採集	（本例無；若有則列補問清單，如「近期用藥史待補」）

5.3　S2 辨證分析與 S3 病機推演

S2 把四診形收斂成證型形，S3 把證型形展開成病機形。一收一放，收要過 ∩(T)，放要環環有據。

提示詞 S2　辨證分析

【任務】把四診形整理成證型形 SyndromeType。

【步驟】①八綱定位 ②臟腑定位 ③列出特徵集合 F(T) ④以交集判準 ∩(T) 對照候選證型 ⑤寫出排除鑑別。

【輸出】病名．證型名稱＋F(T) 清單＋∩(T) 對照＋排除說明（至少一個相似證型為何不取）。

【禁止】特徵不足時輸出「證型未定」並列補問清單，不得硬猜。

提示詞 S3　病機推演

【任務】把證型形展開成病機形 MechanismType：因 → 機 → 證的因果鏈。

【輸出】鏈式表格三欄：環節｜內容｜四診證據；每一環都要指得回四診所見。

【禁止】不得引入四診沒有的病因假設；指不回證據的環必須刪除。

表 5-3　S2–S3 產出範例：證型形與病機形

產出	內容
S2．證型形	不寐．心脾兩虛證
S2．F(T)	難入睡多夢易醒、心悸健忘、食少納呆、倦怠乏力、面色少華、舌淡苔薄白、脈細弱、經量少色淡
S2．∩(T)	脈細弱＋面色少華＋心悸健忘過「心脾兩虛」判準；八綱裡虛、臟腑定位心脾
S2．排除鑑別	非肝鬱化火（無急躁、口苦、脈弦數）；非陰虛火旺（無五心煩熱、舌紅少苔）

產出	內容
S3．因	思慮過度（問診：思慮多、文職）
S3．機	暗耗心血 → 脾失健運、氣血生化乏源 → 心神失養（證據：心悸健忘、食少納呆、倦怠）
S3．證	心脾兩虛而不寐（證據：面色少華、舌淡、脈細弱）

5.4　S4 治法立定與 S5 開方組方

S4 立橋、S5 過橋。S4 的輸出是治法形：一機一法。S5 的輸出是完整處方箋——底方、君臣佐使、加減、煎服法與醫囑，一欄不缺。

提示詞 S4　治法立定

【任務】由病機形立出治法形 `TreatmentType`。
【輸出】治則（如虛則補之）＋治法（如補益心脾、養血安神）＋八法歸類＋一句「為何是此法」。
【判準】治法逐環對應病機鏈；一機一法，不多不少。

提示詞 S5　開方組方

【任務】由治法形開出方劑形 `FormulaType`（處方箋）。
【輸出格式】①底方名 ②君臣佐使四欄（藥味＋劑量＋任務）③加減（每項注明理由）④煎服法與醫囑。
【判準】每味藥指得回治法；劑量在常用範圍；先查配伍禁忌（十八反十九畏）與特殊人群提示。
【聲明】文末標註「僅供示範，臨床由合格中醫師診斷處方」。

S5 的產出範例就是下面這張處方箋。請對照 2.5 節的 BOM 讀：君臣佐使是結構欄，加減是動態欄，醫囑是囑咐欄——三欄齊全，方劑形才算落地。

圖 5-3　處方箋產出範例（S5）

方劑形的完整落地格式

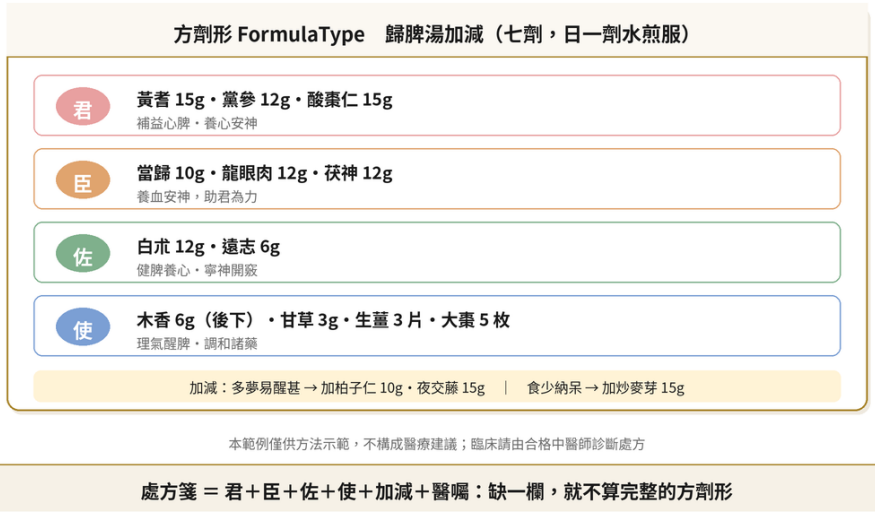


圖 5-3　處方箋產出範例（S5）

表 5-4　S5 產出範例：處方箋（歸脾湯加減・僅供示範）

欄	內容
底方	歸脾湯加減，七劑，日一劑水煎服
君	黃耆 15g、黨參 12g、酸棗仁 15g —— 補益心脾、養心安神
臣	當歸 10g、龍眼肉 12g、茯神 12g —— 養血安神，助君為力
佐	白朮 12g、遠志 6g —— 健脾助運、寧神開竅
使	木香 6g（後下）、甘草 3g、生薑 3 片、大棗 5 枚 —— 理氣醒脾、調和諸藥
加減	多夢易醒甚 → 加柏子仁 10g、夜交藤 15g（強化安神任務）；食少納呆 → 加炒麥芽 15g（助運開胃）
煎服法	日一劑，水煎分溫二服，睡前溫服
醫囑	忌濃茶咖啡；定時就寢；睡前溫水泡腳；兩週後複診

範例聲明：表 5-4 的藥味劑量僅供方法示範，不構成醫療建議；臨床請由合格中醫師診斷處方，並依個別體質與法規調整。

5.5　S6 核方驗收與 S7 複診調方

S6 是出方前的最後一關：把四層準確性逐層跑一次，產出核方報告。任一層不過，指出斷點、退回對應段落重做——退件不是失敗，是這條流水線的自我保護。

提示詞 S6　核方驗收

【任務】四層準確性核方報告。

【輸入】S1–S5 全部產出。

【輸出】四層清單：①∩(T) 對照複核 ②病機鏈逐環檢查 ③君臣佐使與配伍禁忌查核 ④證據鏈回溯。每層給「通過 / 不過 + 原因」。

【處理】任一層不過：標明退件段落（S1–S5），不得帶疑點出方。

圖 5-4　S6 核方驗收：出方之前的最後一關



圖 5-4　S6 核方驗收：出方之前的最後一關

表 5-5　S6 核方報告範例

層	檢查	結果
一	F(T) 與 ∩(T) 對照複核	通過：八綱、臟腑、特徵集合全數相符
二	病機鏈逐環（因機證法方藥）	通過：六環皆有四診證據支撐
三	君臣佐使 + 十八反十九畏 + 劑量	通過：結構齊全、無配伍禁忌、劑量在常用範圍
四	證據鏈回溯	通過：每味藥指得回治法，每句治法指得回病機

S7 把時間接上：兩週後複診，帶著前診卷宗做比對，決定守方、加減或換方，並把這一輪的結論回寫醫案卷。這是時間本形的收束動作——療效變成經驗，經驗變成判準。

提示詞 S7　複診調方

【任務】複診調方並歸檔。

【輸入】前診卷宗（id(C) 串起）＋本次四診。

【輸出】①療效對照（前後四診差值）②證型是否轉變 ③調方決定（守方 / 加減 / 換方）與理由 ④演化紀錄（這次學到什麼）。

【判準】調方理由必須指得回療效對照；換方必須重跑 S2–S6。

表 5-6　S7 複診調方範例（兩週後）

欄	內容
療效對照	已能入睡（潛伏期縮短）；夜醒由二至三次減為一次；心悸減；食納稍回；舌脈同前
證型轉變	無：仍為心脾兩虛，F(T) 增強方向正確
調方決定	守方加減：加柏子仁 10g 強化安神（多夢仍在）；續七劑
演化紀錄	本例驗證「心脾兩虛→歸脾湯」判準有效；「食納未全復」提示下診可再顧脾——回寫醫案卷

本章重點

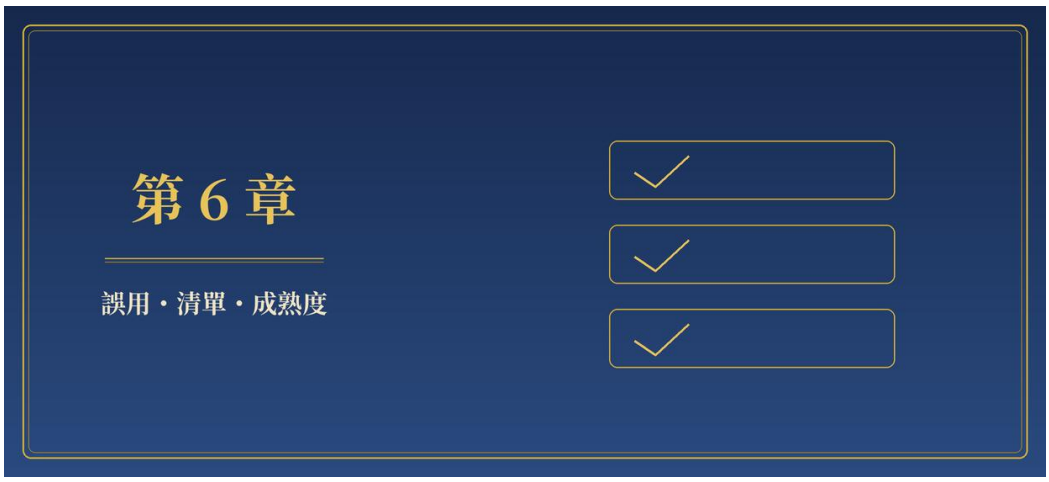
S1–S7 = 七段提示詞×六種產出形 + 核方報告；每段寫法固定：任務→輸入形→輸出形→判準→禁止。

S1 只採集不下判斷；S2 收斂過 ∩(T)；S3 展開要有證據；S4 一機一法；S5 完整處方箋。

S6 四層核方不過就退件；S7 複診比對、調方、歸檔——經驗回寫，越開越準。

方藥內容僅供示範；臨床由合格中醫師診斷處方。

第六章　誤用、清單與成熟度



最後一章收束三樣防身物：誤用五種讓你避開最常見的坑、十問清單讓你出方前自查、成熟度 L1–L4 讓你知道自己在哪一級、往哪裡長。

圖 6-1　誤用五種：錯在哪，正解是什麼

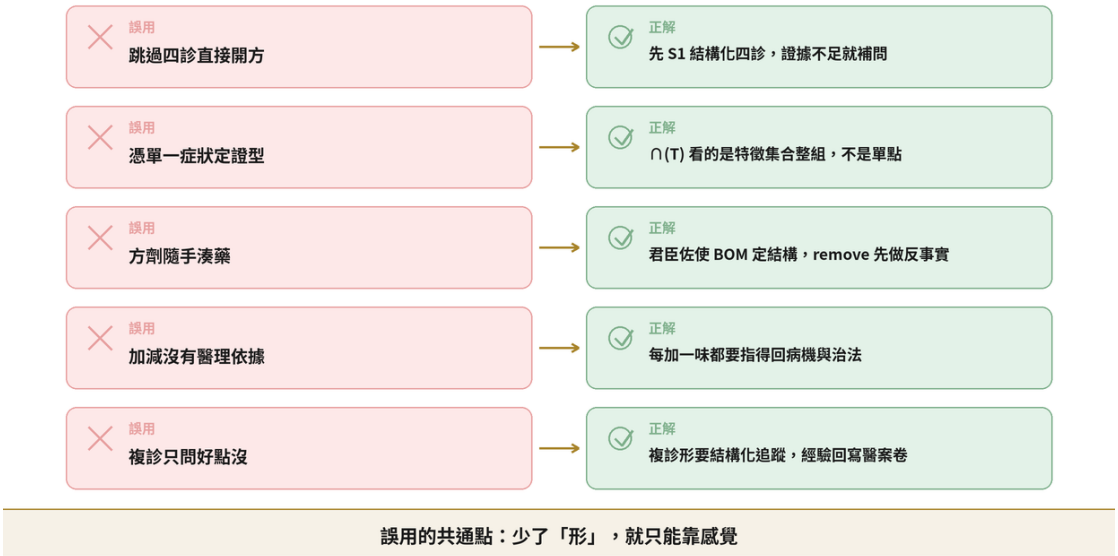


圖 6-1　誤用五種：錯在哪，正解是什麼

6.1　誤用五種

五種誤用有個共通點：少了形，就只能靠感覺。前四種發生在流程裡，第五種發生在流程外——以為複診只是問候。

表 6-1　誤用五種對照

#	誤用	為什麼錯	正解
1	跳過四診直接開方	沒有四診形，證據鏈第一步就斷	S1 先結構化四診；缺欄就補問
2	憑單一症狀定證型	∩(T) 看的是特徵集合整組，不是單點	F(T) 收齊再比對，寫排除鑑別
3	方劑隨手湊藥	無 BOM 結構，藥味說不出任務	君臣佐使定結構，remove 反事實自查
4	加減沒有醫理依據	加一味指不回病機，方就散了	每加一味注明理由，指得回治法
5	複診只問「好點沒」	療效不結構化，經驗就沉澱不下來	複診形四欄照填，回寫醫案卷

6.2　十問清單

出方之前，十個問題逐一過關。任何一問答不上來，退回對應步驟——這份清單就是四層準確性的隨身版。

表 6-2　十問清單

#	問題	對應層
1	四診形齊了嗎？舌脈有欄位、缺漏有標示嗎？	證據鏈
2	F(T) 收齊了嗎？程度與時間寫清楚了嗎？	∩(T)
3	∩(T) 對照跑過了嗎？排除鑑別寫得出來嗎？	∩(T)
4	病機鏈每一環都指得回四診嗎？	演繹骨架
5	治法一機一法對應病機嗎？	演繹骨架
6	每味藥說得出任務、指得回治法嗎？	醫理核方
7	君臣佐使齊全嗎？有說不出任務的藥嗎？	醫理核方
8	十八反十九畏查過了嗎？劑量在常用範圍嗎？	醫理核方
9	特殊人群提示檢查了嗎（妊娠、經期、過敏）？	醫理核方
10	從處方回溯到四診，每一步都答得出「憑什麼」嗎？	證據鏈

6.3　成熟度 L1 到 L4

成熟度分四級，衡量的不是模型多大，而是你的醫案卷多厚、判準多精。L1 會問：四診採集完整、欄位不漏。L2 會辨：辨證有判準，∩(T) 與排除鑑別說得出理由。L3 會開：方從法出，四層核方全過，加減有據。L4 會演化：醫案歸檔回寫，交叉驗收做得確實，越開越準。

圖 6-2　成熟度 L1 到 L4：一步一階

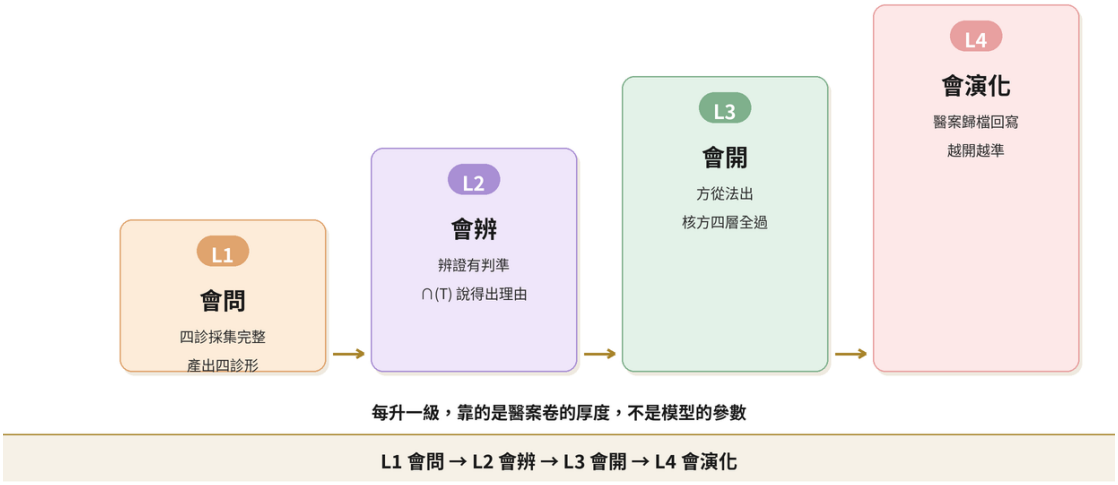


圖 6-2　成熟度 L1 到 L4：一步一階

表 6-3　成熟度 L1–L4

級	名字	達標指標	升級動作
L1	會問	四診形完整；未採集有標示	把補問清單變成習慣
L2	會辨	∩(T) 對照 + 排除鑑別可出示	每次辨證留 F(T) 紀錄
L3	會開	四層核方全過；加減有理由	核方報告入卷，退件率下降
L4	會演化	交叉驗收常態化；判準持續精進	醫案卷複盤 + 招式重構

> **本章重點**
>
> 誤用五種的共通點是少了形；十問清單是四層準確性的隨身版，出方前逐一過關。
>
> 成熟度看醫案卷的厚度：L1 會問 → L2 會辨 → L3 會開 → L4 會演化。
>
> 退件與複盤不是挫折，是判準變精的唯一路徑。

回顧・收束

把全書收成一張圖。六種產出形是東西，四層準確性是關卡，六步驟是路，S1–S7 是招式的手感；空間本形把「人・證・方」看清楚，時間本形把「診・治・調」做下去，Mind AI 承載全程。

圖 R-1　全書一張圖



圖 R-1　全書一張圖

帶走三件事。第一，準確是有結構的：產出是形、判準是 ∩(T)、證據是鏈——三樣齊了，才敢說準確。第二，方法是可重複的：S1 到 S7 照做，每一診都在同一條路上，退件有路徑、演化有紀錄。第三，越用越準是真的：複診回寫醫案卷，交叉驗收磨利判準，L4 不是終點，是開始。

表 R-1　全書檢查清單

章	帶走什麼	自我檢查
第 1 章（認識）	可推理副本；形 + 數；雙本形落點	能一句話向同行說明這套方法
第 2 章（產出）	六種產出形與三括號	六種形的欄位與判準說得出來
第 3 章（準確）	四層準確性保證	「為什麼準」有四層答案
第 4 章（操作）	框架四步驟 + 六步驟 + 三層判斷	照步驟走一診不卡關
第 5 章（演練）	S1–S7 與不寐醫案	換上自己的病人也能跑完流水線
第 6 章（進階）	誤用、十問、成熟度	知道自己現在 L 幾、下一步練什麼

附錄 A　術語・招式・記號速查

本書用到的術語、招式與記號，集中在三張表。理論細節回到本形學原典；這裡只求「用的時候查得到」。

表 A-1　術語速查

術語	英文 / 記號	在本書的意思
形	Type	結構化的產出單位；英文一律用 Type，不用 Form
四診形	ExamType	望聞問切的結構化記錄
證型形	SyndromeType	辨證結論：病名 + 證型，F(T) 過 ∩(T)
病機形	MechanismType	因→機→證因果鏈
治法形	TreatmentType	治則 + 治法 + 八法歸類
方劑形	FormulaType	君臣佐使 BOM + 加減 + 醫囑
複診形	FollowType	療效對照 + 調方決定 + 演化紀錄
特徵集合	F(T)	證型形收的特徵總集
交集判準	∩(T)	判定「歸不歸入這個形」的規則
身份錨	id(C)	容器（病患・病程）的身份錨定
組成集合	{ }	BOM：由什麼組成
容器集合	( )	住在哪裡、身份是誰
抽象集合	[ ]	歸入哪一類

表 A-2　時間本形十四招 × 中醫落點

組	招式	問診開方落點
找招	形時間函式搜尋	以四診形檢索相似醫案
找招	設計搜尋與萃取	從醫案萃取證型特徵與成方模式
找招	設計模式	套用配伍模式（如君臣佐使結構）
出招	邏輯生成與應用	辨證論治的推理生成
出招	函式生成與應用	治法與方劑的生成
出招	設計（創造與創新）	組方加減——開方即設計
想招	解題	療效不佳的歸因與對策
想招	分析	四診資訊拆欄、證型鑑別

組	招式	問診開方落點
想招	推理（因果・果因・模擬・統計・逆向）	病機因果鏈；從方測證的逆向驗證
想招	思考法（正向・逆向・水準・垂直・第一性原理）	疑難案例的多角度辨證
練招	持續學習	醫案歸檔、經驗累積
練招	重構與重組	調方重構、方組重排
練招	研發與探索	新方探索、治法試探
練招	自我演化	交叉驗收回寫判準，越開越準

表 A-3　記號速查

記號	讀法	用途
[ ]	方括號	抽象集合：歸不歸入 [不寐]
( )	圓括號	容器集合：(林小姐)、(本次診次)
{ }	花括號	組成集合：{歸脾湯加減} 的 BOM
∩(T)	交集判準	形的會員判定規則
F(T)	特徵集合	證型形收的特徵總集
id(C)	身份錨	容器的身份錨定
remove	移除判準	三級反事實：單味 / 藥對 / 方根

全書聲明：本書方藥內容（含林小姐醫案之藥味、劑量、加減）僅供方法示範，不構成醫療建議；臨床診療請由合格中醫師診斷處方。

形 = Type，不是 Form。理論只用不教；平台只引不述。

MIND AI

AGI 永恆之道

知識統一 · 思維統一 · 智慧統一

本形學 Ontypology · Mind Model · Mind AI

空間本形（形）＋時間本形（招）＝可推理副本



AI 中醫問診與開方 · 產出準確使用方法完全方案

方藥內容僅供方法示範，不構成醫療建議